



נוהל מס': 037.17
שם הנוהל: טיפול בכאב לאחר לידה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

תפוצה	תחום הנוהל : מיילדות		06.2017 מהדורה: 3 תאריך עדכון: 12.2017
	שם הנוהל: טיפול בכאב לאחר לידה		
	כותב הנוהל: דר' אילוז רועי ודר' צפורי יניב		
	האחראי על ביצוע הנוהל: פרופ' וינר זאב	מאשר הנוהל : פרופ' וינר זאב	
מס' דפים: 7	על החתום:	על החתום:	נספחים : 1. הערכת עוצמת כאב Pain Score 2. פרוטוקול לטיפול בכאב לאחר ניתוח קיסרי ולידה נרתיקית.

תוכן העניינים

הנושא

1. רקע ומטרות הנוהל
2. הגדרות ומונחים
3. סמכות ואחריות
4. עקרונות הנוהל
5. דיווח ותיעוד
6. ביבליוגרפיה
7. נספחים

העמוד

- 2
- 2
- 2
- 2-4
- 4
- 4
- 5-6

1. רקע ומטרות הנוהל

יולדות מציגות מגוון רחב של כאב ותגובה לכאב לאחר לידה. נשים רבות מודאגות לגבי השפעת התרופות על עצמן ועל הילוד. תגובתן של יולדות לכאב מושפעות לרוב ממהלך הלידה עצמה ומהסביבה התומכת סביב ולאחר הלידה. כאבים ותשישות לאחר לידה נרתקת או בניתוח קיסרי מהווים את שתי התלונות השכיחות ביותר. מומלץ להתאים טיפול לפי סוג ומקור הכאב. פרוטוקול זה מתאר את הפרטים לגבי שיכון כאב תרופתי לאחר לידה.

2. הגדרות ומונחים

2.1 כאב חריף – כאב הנמשך לפרק זמן קצר ובדרך כלל חולף לאחר טיפול בסיבה

שגרמה לכאב.

2.2 הערכת כאב חריף – תהליך קבלת מידע ותייעוד של המטופל/ת לגבי תחושת

הכאב והאפקטיביות לאחר מתן משככי כאבים.

2.3 הערכת עוצמת כאב – מערכת ניקוד המציינת את רמת עוצמת הכאב ו/או מידת

הקלה בכאב בעקבות התערבות.

3. סמכות ואחריות

צוות האחיות, מיילדות, והצוות הרפואי במחלקת נשים ויולדות ומחלקת הרדמה

אחראים לספק ליולדת מידע על האמצעים לשיכון כאב לאחר לידה.

4. עקרונות הנוהל על פי אופן הלידה וסוגי הכאב השונים

4.1 כאב בעקבות לידה נרתקת

4.1.1 כאב בשל התכווצות הרחם - הכאב מופיע לאחר הלידה כאשר הרחם מתכווץ

בצורה היפרטונית, במיוחד בנשים וולדניות ויותר כאשר הן מניקות (בשל הפרשת

אוקסיטוצין מוגברת). נמצא שטיפול ב-NSAIDs נותן מענה טוב לכאבים אלו ואף

עולה לעיתים, על טיפול באופואידים [1].

4.1.2 כאב בשל פגיעה בפרינאום - כאב זה ניתן לטיפול באמצעות NSAIDs או

ACETAMINOPHEN. מטה-אנליזה הדגימה הצלחה בהקלת כאב על ידי NSAIDs

במהלך 4-6 שעות שלאחר הטיפול, וכן פחות צורך בטיפול המשך לאחר מכן [2].

כמו כן, שימוש בתחבושות קרח מצוי בשימוש רווח, ונמצא כמקל על כאב זה למשך

24-72 שעות.

4.2 כאב בעקבות ניתוח קיסרי (נספח 2)

▪ השאיפה הינה טיפול קבוע בנוסף לטיפול תומך בכאב מתפרץ.

▪ צמצום השימוש באופואידים.

▪ התאמת הטיפול לנשים החפצות בהנקה.

▪ עדיפות לטיפול מולטי-מודאלי.

הטיפול הבסיסי ל-24 השעות הראשונות לאחר ניתוח קיסרי יתבצע סביב השעון ויכלול

שילוב של IBUPROFEN פומי P.O במינון של 400 מ"ג כל 6 שעות (עד מקסימום 1,600 מ"ג ליממה) ואקמול פומי או דרך הוריד במינון של 1 גרם כל 6 שעות. במידה וקיימת רגישות לאחת התרופות, נא לתת את התרופה לה היולדת אינה רגישה ולהוסיף במידת הצורך ORAMORPH פומי של 20 מ"ג (עד 4 מנות ביום, סה"כ 80 מ"ג ליממה) או MIR במינון פומי של 15 מ"ג (עד 4 מנות ביום, סה"כ 60 מ"ג ליממה). בכל מקרה של VAS בין 5-10 שאינו מגיב לאנלגטיקה הנ"ל, או יש צורך במתן מורפינים, נא לקרוא לרופא המחלקה / תורן חדר לידה על מנת להעריך את היולדת.

לאחר 24 שעות מהניתוח הקיסרי ניתן לעבור למשככי כאבים של סיס S.O.S שוב, ניתן לבחור בין IBUPROFEN פומי P.O במינון של 400 מ"ג כל 6 שעות (עד מקסימום 1,600 מ"ג ליממה) או אקמול פומי / דרך הוריד במינון של 1 גרם כל 6 שעות (עד 4 גרם ליממה). **בנוסף, ביולדות שאינן מיניקות**, אפשר לתת OPTALGIN נוזלי במינון פומי (P.O) של 1-2 מ"ל (0.5-1 גרם) עד 4 גרם ליממה או טבליות TRAMADEX FLASHTAB במינון 50 מ"ג (התחלת טיפול בטיטרציה, ביום הראשון טבליה אחת וביומיים הבאים עד שתי טבליות מציצה).

4.3 כאב משני לגודש בחזה

לרוב מופיע כשלושה עד חמישה ימים לאחר הלידה, אך יכול להופיע מוקדם, בין 24-72 שעות לאחר הלידה. לרוב מלווה בכאב ואי נוחות ולעיתים בחוס סב-פברילי. הבעיה חולפת מעצמה מספר ימים לאחר מכן. טיפול כאב מומלץ הינו קומפרסים של קרח וכן אקמול/IBUFEN, ללא העדפה ספציפית.

הטיפול המומלץ בנשים שאינן מעוניינות בהנקה הינו שימוש בחזיות לחץ ומניעת גירוי פטמות. טיפול זה מאפשר דיכוי ייצור חלב בכ- 60-70% מהיולדות. כמו כן, ניתן להיעזר, בהתוויה המתאימה, בטבליות DOSTINEX.

4.4 כאב פטמות משני להנקה

נשים נוטות לסבול מכאבי פטמות בשל סדקים ברקמת הפטמה משניים להנקה. למעט הכאב, מצב זה מהווה גורם סיכון לדלקת רקמת השד (MASTITIS). כמו כן, כאבים אלו יכולים להוביל, בניגוד להמלצה להניק, להפסקת הנקה. הטיפול בשלב ראשון הינו תצפית יועצת הנקה ושיפור טכניקת ההנקה אשר יכול להקטין את הכאב והטראומה לפטמה. מבחינת טיפול בתכשירים מקומיים כמו לנולין וגליצרין, אף אחד מהם לא הוכיח כמקל על כאבים אלו במטה-אנליזה שפורסמה ב-2014 בנושא [3], אך יש בכל זאת להמליץ ליולדת להיעזר בהם, וכן קיים תרחיף זמין במוסדנו. חשוב לידע את היולדות שלרוב כאבים אלו מוקלים עצמונית לאחר כשבוע מהלידה.

4.5 טיפול תרופתי בכאב בזמן הנקה :

הן ACETAMINOPHEN והן NSAIDS (כדוגמת IBOPRUFEN ו-DICLOFENAC) מגיעים לחלב האם, אך הם נמצאו מתאימים מבחינת פרופיל הבטיחות לשימוש במינונים המקובלים [5]. מבחינת אופואידים, אשר לעיתים נדרשים לאחר ניתוח קיסרי, גם אלו ימצאו בחלב האם, וכן יכולים להשפיע על ערנות היילוד, רפלקס היניקה שלו וכן לגרום לעצירות. מאידך, נחיצותו לעיתים נדרשת בשל ירידה בהיענות להנקה משנית לכאב. קיימים מגוון תכשירים אופואידים, אך לפי איגוד רופאי הילדים האמריקאי (AAP) וכן האיגוד

נוהל מס': 037.17
שם הנוהל: טיפול בכאב לאחר לידה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



האמריקאי לנשים ומיילדות (ACOG), העדיפות הינה למורפין (MORPHINE) או הידרומורפון (HYDROMORPHON) על פני קודאין או טרמדול (TRAMADOL), [6], [7]. מבחינת השימוש, העדיפות היא להשלים הנקה טרם הטיפול וכן להמשיך הנקה כשעה-שעתיים לאחר הטיפול. כמו כן, מומלץ להגביל את הטיפול התרופתי ולעבור לטיפול לא-אופואידי מוקדם ככל הניתן. במקביל, יש להנחות את היולדת לגלות ערנות ליילוד מבחינת ההשפעות לעיל. לציין, יש להימנע משימוש ב-ASPIRIN בשל סכנה להתפתחות REYE SYNDROME ליילוד.

4.6 כאב משני לטחורים

מחקר פרוספקטיבי הראה ש-8% מהיולדות חוות פקקת ורידית בטחור חיצוני במהלך הריון מתקדם [4], וכן 35% מהיולדות סובלות מפגיעה/פציעה אנלית במהלך משכב הלידה (Anal Fissure, עצירות). כ-90% ממקרי הטחורים יופיעו כבר ביום הראשון לאחר הלידה. ההמלצה הינה לטפל בטחורים סימפטומטיים ע"י דיאטה עשירה בסיבים, טיפול במרכי צואה (GLYCERIN, AVILAC), אלחוש מקומי (עורקאי בקרם/גיל, Lidocaine base) וכן טיפול במשחות סטרואידליות (RECTOZORIN) להקטנת הכאב והדלקת.

5. דיווח ותיעוד

במהלך השהות ביולדות יש לדווח לצוות המחלקה המטפל על מידת הכאב, או דרך שיטת VAS או במלל פתוח וכן לציין אם היולדת מעוניינת בטיפול לכאב, וכן את האפשרות הנבחרת ע"י היולדת. במידה והיולדת מעוניינת באנלגטיקה אופואידית – יש לציין שהוסברו לה הסיכונים שבכך, כפי המופיע בנספחים. בכל מקרה של כאב אשר לא מגיב למתן משככי כאבים, או בכל תגובה חריגה לכאב או טיפול בכאב, יש לקרוא לרופא תורן בהקדם על מנת לבצע הערכה קלינית של היולדת.

6. ביבליוגרפיה

- [1] E. Declercq, D. K. Cunningham, C. Johnson, and C. Sakala, "Mothers' reports of postpartum pain associated with vaginal and cesarean deliveries: results of a national survey," *Birth*, vol. 35, no. 1, pp. 16–24, Mar. 2008.
- [2] F. Wuytack, V. Smith, and B. J. Cleary, "Oral non-steroidal anti-inflammatory drugs (single dose) for perineal pain in the early postpartum period," *Cochrane database Syst. Rev.*, vol. 7, p. CD011352, Jul. 2016.
- [3] C.-L. Dennis, K. Jackson, and J. Watson, "Interventions for treating painful nipples among breastfeeding women," *Cochrane database Syst. Rev.*, no. 12, p. CD007366, Dec. 2014.
- [4] L. Abramowitz *et al.*, "Anal fissure and thrombosed external hemorrhoids before and after delivery," *Dis. Colon Rectum*, vol. 45, no. 5, pp. 650–5, May 2002.
- [5] A. Montgomery, T. W. Hale, and Academy Of Breastfeeding Medicine, "ABM clinical protocol #15: analgesia and anesthesia for the breastfeeding mother, revised 2012," *Breastfeed. Med.*, vol. 7, no. 6, pp. 547–53, Dec. 2012.
- [6] S. Announcement, "FDA restricts use of prescription codeine pain and cough medicines and tramadol pain medicines in children ; recommends against use in breastfeeding women," 2017.
- [7] H. C. Sachs and Committee On Drugs, "The transfer of drugs and therapeutics into

נוהל מס': 037.17
שם הנוהל: טיפול בכאב לאחר לידה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



רמב"ם הקריה הרפואית לבריאות האדם

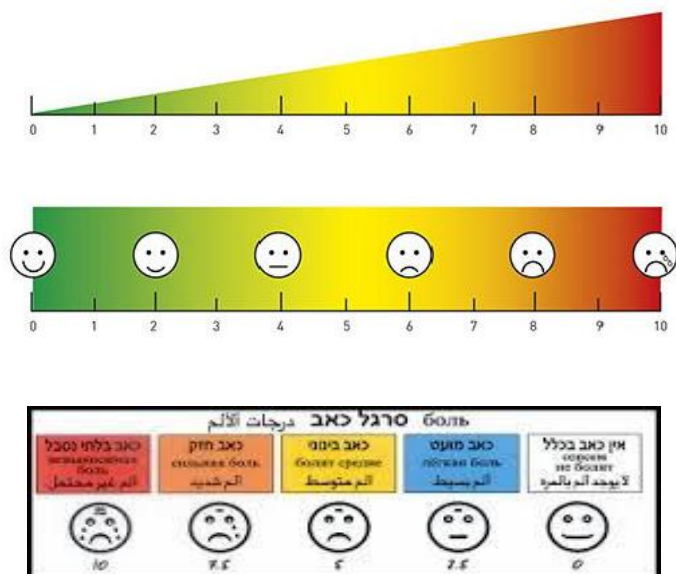
human breast milk: an update on selected topics.” *Pediatrics*, vol. 132, no. 3, pp. e796-809, Sep. 2013.

7. נספחים:

נספח 1: הערכת עוצמת כאב Pain Score

כלים להערכת עוצמת הכאב

סרגל כאב אנלוגי Visual Analogue Scale



נספח 2: פרוטוקול לטיפול בכאב לאחר ניתוח קיסרי ולידה נרתיקית.

נוהל מס': 037.17
שם הנוהל: טיפול בכאב לאחר לידה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



רמב"ם הקריה הרפואית
לבריאות האדם

מחלקה 0-24 שעות

Ibuprofen 400 mg X 4/d
AND
PO/IV paracetamol 1 g x 4/d

- אם ידועה רגישות לאחת התרופות, יש לטפל בתרופה השנייה סביב השעון ולהוסיף תרופת S.O.S לפי הצורך.

VAS 0-10
Around the clock

1. S.O.S PO ORAMORPH 20 mg (up to 4 doses daily)
2. S.O.S PO MIR 15 mg (up to 4 doses daily)

בכל מקרה של VAS בין 5-10 שאינו מגיב לאנלגטיקה הנ"ל, או יש צורך במתן מורפינים, נא לקרוא לרופא המחלקה / תוך חדר לידה על מנת להעריך את היולדת.

מחלקה מעל 24 שעות

S.O.S Ibuprofen 400 mg (up to 1,600 mg/d)
AND/OR
S.O.S PO/IV paracetamol 1 g up to 4g/d

1. S.O.S PO ORAMORPH 20 mg (up to 4 doses daily)
2. S.O.S PO MIR 15 mg (up to 4 doses daily)

VAS 1-5

VAS 5-10

בכל מקרה של VAS בין 5-10 שאינו מגיב לאנלגטיקה הנ"ל, או יש צורך במתן מורפינים, נא לקרוא לרופא המחלקה / תוך חדר לידה על מנת להעריך את היולדת.

* לאחר לידה נרתיקית או לידה מכשירנית יש לפעול על פי פרוטוקול מחלקה מעל 24 שעות

הנחיות לשחרור

S.O.S PO paracetamol 1g up to 4 g/d
AND/OR
S.O.S PO Dipyrone (Optalgin) 1g up to 4 g/d אם אינר מניקה

VAS 1-5

נוהל מס': 037.17
שם הנוהל: טיפול בכאב לאחר לידה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



רמב"ם הקריה הרפואית לבריאות האדם

התוויות נגד ל Acamol:

- מחלת כבד פעילה
- לאחר ניתוח כריתת כבד
- מצב תזונתי ירוד
- שימוש מופרז באלכוהול

התוויות נגד ל NSAID:

- אי ספיקת כליות
- דימום פעיל
- מחלה פפטיט פעילה
- סיכון גבוה לאירוע טרומבוטי
- הפרעת קרישה או טיפול בנוגדי קרישה
- Pre-eclampsia
- HELLP syndrome
- Patent ductus dependent newborn (אמהות לתינוקות עם מום לב התלויים ב ductus arteriosus פתוח. עלול להיסגר בחשיפה ל NSAID)
- טיפול קבוע מתמשך בסטרואידים
- (לאחר ניתוח מעקפים / מחלת לב איסכמית פעילה)

אופיאטים והנקה:

- מורפין עובר הכי פחות בחלב אם והוא תרופת הבחירה.
- קודאין, אוקסיקוד וטרמדול עוברים מטבוליזם בכבד לצורתם הפעילה ובאנשים מסוג fast metabolizers עלולים לעלות לריכוז גבוה שיעבור בחלב אם ועלול לגרום לדיכוי נשימתי / דיכוי הכרה ביונק. לכן יש אזהרת FDA לא לתת בנשים מיניקות.
- פטידין עלול לגרום לדיכוי נשימתי / דיכוי הכרה ביונק, וכן לרעילות מרכזית (התכווצויות). אינו מומלץ בנשים מיניקות.

- יש לבצע ולתעד אומדן כאב מיד בחזרה למחלקה מחדר ניתוח / חדר לידה.
- ב-24 השעות הראשונות לאחר לידה נרתיקית או ניתוח קיסרי מומלץ לתת טיפול תרופתי סביב השעון ותוספות מורפין לפי הצורך על פי הפרוטוקול
- אם היה אומדן כאב מעל 5, יש לבצע ולתעד אומדן כאב חוזר לאחר 90 דקות.
- אם ניתן טיפול לכאב (תרופתי או אחר), יש לבצע ולתעד אומדן כאב חוזר עד 90 דקות מההתערבות.
- אם אין הקלה או יש החמרה באומדן כאב חוזר יש לעבור לחלופת טיפול על פי רמת הכאב בפועל בהתאם לפרוטוקול.
- שילוב אמצעים לא תרופתיים כולל רפואה משלימה או שיחה עם איש צוות – מומלץ.
- במטופלת עם כאב בלתי נשלט למרות טיפול על פי הפרוטוקול אפשר לזמן יעוץ מהשרות לטיפול בכאב חריף.

מאגר מידע לתרופות בהנקה: LACTMED

<https://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed.htm>